

KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

COORDINATORE CLINICO

Servizi e figure del presidio

Il kit del coordinatore clinico

Materiale didattico — Workshop KIREO

Apri un'enoteca a Centocelle, Roma

Cosa devi produrre

La dottoressa Ferretti serve 3.200 persone su quattro comuni montani. Età media 54 anni, molti over 75 con più patologie croniche. L'ospedale è a 45 minuti di curve. Il tuo lavoro è definire cosa può fare concretamente un presidio di comunità in quel contesto.

La consegna richiesta

- Elenco dei servizi erogabili nel presidio, con priorità
- Figure professionali necessarie e loro inquadramento
- Percorso tipo di un paziente cronico, dalla presa in carico al follow-up
- Cosa NON si può fare lì e va comunque inviato all'ospedale

Il quadro normativo: cosa dice il DM 77

Il Decreto Ministeriale 77 del 23 maggio 2022 definisce modelli e standard per l'assistenza territoriale. È il riferimento obbligato per qualsiasi presidio di comunità: distingue tra Case della Comunità **hub** (grandi, con più servizi) e **spoke** (più piccole, di prossimità). Un borgo di 3.200 abitanti rientra nella logica spoke.

Elemento	Casa di Comunità hub	Casa di Comunità spoke
Bacino di riferimento	40.000–50.000 abitanti	Aree a bassa densità, prossimità
Apertura	24 ore su 24, 7 giorni	Orari ridotti, secondo il bisogno locale
Medici di medicina generale	Presenza continuativa	Presenza programmata
Infermiere di comunità	Sempre presente	Presente, anche a rotazione
Specialisti ambulatoriali	Più branche	A rotazione o in telemedicina
Diagnostica di base	Presente	Essenziale o in collegamento
Punto prelievi	Sì	Sì, spesso il servizio più richiesto

Fonte: DM 23 maggio 2022 n. 77, Regolamento sui modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN; linee guida per la salute nelle aree interne.

I servizi da attivare, in ordine di priorità

Non si apre tutto insieme. Questi sono i servizi ordinati per rapporto tra impatto sulla popolazione e difficoltà di attivazione.

Servizio	Chi lo eroga	Impatto	Difficoltà
Punto prelievi	Infermiere	Altissimo: evita 45 min di viaggio	Bassa
Ambulatorio infermieristico	Infermiere di comunità	Medicazioni, terapie, controlli	Bassa
Telemonitoraggio cronici	Infermiere + MMG	Riduce riacutizzazioni e ricoveri	Media
Televisita specialistica	Specialista ospedaliero da remoto	Cardiologia, diabetologia, pneumologia	Media
Teleconsulto MMG-specialista	Medico + specialista	Risposte rapide senza spostare il paziente	Media
Prevenzione e screening	Team + volontari	Adesione screening in aree interne è bassa	Bassa
Educazione terapeutica	Infermiere	Autogestione della cronicità	Bassa
Diagnostica di primo livello	Tecnico o infermiere	ECG, spirometria, holter	Alta

L'infermiere di famiglia e comunità

È la figura chiave di questo modello, prevista esplicitamente nei piani per le aree interne. Non è un infermiere ambulatoriale: lavora sul territorio, conosce le famiglie, fa da ponte tra il paziente e il sistema. Nel tuo progetto devi definire cosa fa concretamente ogni settimana.

- Presa in carico proattiva dei pazienti cronici, non solo su chiamata
- Visite domiciliari programmate agli allettati e ai fragili
- Gestione del telemonitoraggio: legge i dati, allerta il medico quando serve
- Educazione terapeutica: insegna a gestire terapia, dieta, dispositivi
- Collegamento con i servizi sociali del Comune

Le domande che la dottoressa ti farà

- "Ho una signora di 82 anni con scompenso cardiaco. Come cambia la sua vita con questo presidio?"
- "Chi lo paga l'infermiere di comunità? È assunto dall'ASL o da chi?"
- "Quante ore alla settimana devo starci io? Ho già gli ambulatori nei quattro comuni."
- "Cosa faccio se arriva un'emergenza vera? Non ho un defibrillatore, non ho un'ambulanza."
- "I miei pazienti si fidano di me. Si fideranno di uno specialista che vedono su uno schermo?"

Prossimo passo — definisci servizi e figure, poi vai nella chat. La dottoressa ragiona per casi clinici concreti, preparati.